



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
DIKLAT MANAJEMEN FASILITAS
DAN KESELAMATAN (MFK)
TAHUN 2025

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



TERM OF REFERENCE (TOR)
DIKLAT MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)
TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dengan kegiatan pokok berupa pelayanan medis, baik preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Sudah menjadi kewajiban institusi rumah sakit untuk memberikan pelayanan bagi penderita sebagai konsumen beserta pengunjung lainnya. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit perlu mempunyai pegawai atau karyawan yang perilakunya termotivasi secara baik, mengarah kepada tujuan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya tidak mudah terganggu oleh gangguan-gangguan kecil.

Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik dan sumber-sumber cedera ringan lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anastesi, gangguan psikososial dan ergonomi. Semua potensi bahaya tersebut diatas, jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 23 dinyatakan bahwa Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan, mudah terjangkit penyakit atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 orang. Jika memperhatikan isi dari pasal diatas maka jelaslah bahwa rumah sakit termasuk ke dalam kriteria tempat kerja dengan berbagai ancaman bahaya yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, tidak hanya terhadap para pelaku langsung yang bekerja di rumah sakit, tapi juga terhadap pasien maupun pengunjung rumah sakit. Sehingga sudah seharusnya pihak pengelola rumah sakit melakukan manajemen K3.

Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi bahaya-bahaya lain yang mempengaruhi situasi dan kondisi di rumah sakit, yaitu kecelakaan (peledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik, dan sumber-sumber cedera lainnya), radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anastesi, gangguan psikososial dan ergonomi. Semua potensi bahaya tersebut di atas, jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit.

Bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan atau membuang B3.

Kebakaran adalah sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan yang dapat menyebabkan penderitaan dan malapetaka, kejadian kebakaran selalu membawa kerugian material dan korban. Kebakaran terjadi apabila terpenuhi



persyaratan segitiga api, yaitu adanya bahan bakar, panas dan udara. Akan tetapi, studi lanjut mengenai fisika dan kimia menyatakan bahwa peristiwa kebakaran mempunyai tambahan unsur, yaitu rantai reaksi kimia (*chain reaction*). Konsep ini dikenal dengan bidang empat api (*tetrahedron of fire*). Secara teori dengan memotong salah satu unsur tersebut maka dapat mencegah kejadian kebakaran.

Seiring meningkatnya ukuran, kompleksitas bangunan gedung, dan perkembangan teknologi yang digunakan maka sudah seharusnya diiringi pula dengan peningkatan perlindungan terhadap pekerja yang sebagaimana telah diatur pada UU No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hal ini berarti mencakup jaminan keselamatan kerja dari bahaya kebakaran seperti yang tertuang pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 ayat 3 yang berbunyi mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran.

Rumah Sakit Prima Husada sebagai suatu institusi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan operasionalnya di tunjang oleh sarana, prasarana dan peralatan yang terdiri dari berbagai macam jenis dan fungsi yang saling menunjang satu sama lainnya.

Sarana, prasarana dan peralatan yang ada di dalam rumah sakit umumnya terdiri dari peralatan medik dan non medik dengan kategori sebagai berikut :

- a) Untuk kategori peralatan medis, seluruh peralatan kesehatan yang dipakai untuk menetapkan diagnose, pemeriksaan, terapi dan penyembuhan.
- b) Untuk kategori peralatan non medis, berupa bangunan gedung, serta seluruh utilitasnya termasuk mesin dan peralatan berat seperti Genset, AC, Supply Listrik dan lain-lain

Pelayanan Pemeliharaan Fasilitas Rumah Sakit adalah kegiatan pelayanan pemeliharaan fasilitas seperti preventive maintenance, reaktif maintenance, curative maintenance dan juga kalibrasi pada peralatan medis dan non medis di Rumah Sakit agar dapat dipakai untuk kebutuhan penyembuhan pasien selain itu juga untuk kenyamanan dan keselamatan pasien, pengunjung dan staff baik rawat inap maupun rawat jalan.

Adapun untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) sebagai salah satu bagian penunjang pelayanan yang mempunyai bidang tugas melakukan pemeliharaan, pengecekan dan perbaikan sarana prasarana serta peralatan, baik peralatan penunjang umum maupun peralatan medis di rumah sakit harus turut serta meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan yang mengarah pada profesionalisme dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus menerus.

Dalam upaya untuk menjamin bahwa kegiatan operasional rumah sakit selalu dalam keadaan siap memberikan pelayanan kesehatan maka seluruh utilitas penunjang harus secara berkesinambungan melakukan pemeliharaan dan pengecekan dengan baik secara berkala, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayanan kesehatan.

Salah satu program dari Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah pengembangan manajemen tanggap darurat, tidak hanya di dilaksanakan oleh komite K3RS tetapi seluruh staf Rumah Sakit Prima Husada Malang harus mendapatkan pengembangan manajemen tanggap darurat.



Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka tim K3RS Rumah Sakit Prima Husada Malang akan mengadakan Pelatihan pemadam kebakaran dan evakuasi bencana untuk seluruh staf Rumah Sakit Prima Husada Malang.

2. Dasar Hukum

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/SK/VI/1993 tentang penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1653/Menkes/5K/XII/2005 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.

3. Maksud dan Tujuan

- Maksud
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman terkait Fasilitas dan keselamatan di Rumah Sakit
- Tujuan
 - Mengetahui program K3RS
 - Mengetahui program MFK
 - Mengetahui identifikasi risiko keselamatan dan keamaan di unitnya
 - Mengetahui penanganan bila terjadi bencana
 - Mengetahui penanganan dan penggunaan B3

II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Susunan Panitia

NO	SUSUNAN PANITIA	NAMA	TUGAS
1	Ketua Panitia	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara.
2	Sekretaris	Annadiva Fikri Chandra Maulana, S.Psi	Bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen
3	Bendahara	Novi Ratnasari, SE	Bertanggung jawab terhadap anggaran dana Diklat
4	Sie Dokumentasi	Maja Tito Sadewo, S.Kom	Bertanggung jawab terhadap dokumentasi Diklat
5	Sie Penunjang	Mukhamad Eriko Firdaus, S.Kom	Bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan.

2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

- Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025
- Pukul : 1. 08.00 – 09.30 (Gelombang 1)
2. 10.00 – 11.30 (Gelombang 2)
- Tempat : Hall Sakura Lt. 5 RS Prima Husada Malang

3. Rencana Rapat Panitia Penyelenggaraan

- Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
- Pukul : 10.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat PT. DPM



4. Sasaran atau Peserta
 - a. Seluruh Staf RS Prima Husada
 - b. Staf yang bekerja $\pm$ 1 tahun

5. Susunan Acara Lengkap

NO	JAM	DURASI	MATERI	PETUGAS
Gelombang 1				
1	08.00 – 08.15	15 menit	Absensi	Tim
2	08.15 – 09.15	60 menit	Pertanyaan Soal Pitstop a. Risiko Keselamatan di Rumah Sakit b. Risiko Keamanan di Rumah Sakit c. Pengelolaan B3 d. Proteksi Kebakaran e. Pengamanan Peralatan Medis f. Pengamanan Sistem Utilitas g. Kedaruratan Bencana	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
Gelombang 2				
3	12.00 – 12.15	15 menit	Absensi	Tim
4	12.15 – 13.15	60 menit	Pertanyaan Soal Pitsop a. Risiko Keselamatan di Rumah Sakit b. Risiko Keamanan di Rumah Sakit c. Pengelolaan B3 d. Proteksi Kebakaran e. Pengamanan Peralatan Medis f. Pengamanan Sistem Utilitas g. Kedaruratan Bencana	Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

6. Narasumber / Pemateri
 - a. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM
7. Media
 - a. Meja
 - b. Alat Tulis
8. Metode
 - a. Pitstop / (Tanya Jawab)



9. Kebutuhan Anggaran

NO	DESKRIPSI	JUMLAH SATUAN	TOTAL
1.	Fee untuk pemateri	0	0
2.	Konsumsi pemateri dan panitia	5 nasi kotak x Rp.15.000	Rp.75.000
	Konsumsi peserta	Air mineral + kue dari dapur	0
3.	Sertifikat	Soft copy	0
Total Biaya			Rp. 75.000

III. MONITORING – EVALUASI

- Monitoring
 - Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung
- Evaluasi
 - Evaluasi Diklat dilakukan oleh kepala ruang masing – masing dan disupervisi oleh Komite K3RS

IV. PENUTUP

Demikian TOR ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan ini. Suksesnya acara ini memerlukan dukungan dan kerjasama dari seluruh staf yang ada dan agar tujuan orientasi tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Malang, 18 Februari 2025

SDM RS Prima Husada

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Annadiva Fikri Chandra
Maulana, S.Psi

Ketua Panitia

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah